

Quadro 5.4. Vacina contra o *Haemophilus influenzae* conjugado tipo b

Tipo de vacina*	Polissacarídeo conjugado a uma proteína (toxóide diftérico, toxóide diftérico mutante não tóxico – CRM-27, membrana externa da <i>Neisseria meningitidis</i> B e toxóide tetânico).		
Número de doses	No primeiro ano de vida: 3 doses, com intervalo de 60 dias.		
Idade recomendada	De 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias • Para os menores de 1 ano = 3 doses; • Para os maiores de 1 ano = 1 dose.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Observar o prazo de validade: utilizar por até 5 dias após a abertura do frasco.
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Subcutânea ou intramuscular – conforme laboratório produtor		
Dose (volume)	0,5ml (ou conforme laboratório produtor)		
Eficácia esperada	Próxima de 100% (após 3ª dose)		
Duração da imunidade	Prolongada		
Indicações	Na rotina: crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; Nos CRIEs: ver manual CRIE, p.99.		
Contraindicações	As contraindicações gerais Hipersensibilidade a qualquer componente da vacina		
Eventos adversos	• Reações locais: dor, eritema, edema, calor e enduração • Reações sistêmicas: febre, erupção cutânea, irritabilidade e sonolência		

* A vacina Hib NÃO protege contra as infecções causadas por outros tipos de *Haemophilus influenzae*, nem contra as meningites de outras origens.

Quadro 6. Características gerais da poliomielite

Agente etiológico	Enterovírus da família Picornaviridae, denominado poliovírus de três sorotipos I, II, III.
Reservatório	O homem

Modo de transmissão	De pessoa a pessoa, pelas secreções nasofaríngeas (de uma a duas semanas após a infecção), pela água e pelos alimentos contaminados com fezes de doentes ou portadores.
Período de incubação	2 a 30 dias (em geral de 7 a 12 dias).
Transmissibilidade	7 a 10 dias antes do início dos sintomas, até cerca de seis semanas depois (em geral, uma semana após).
Suscetibilidade	Pela infecção natural por vírus selvagem (imunidade duradoura ao tipo antigênico específico de polivírus causador da infecção). Universal, mas somente de 0,1% a 2% dos infectados desenvolvem a forma paralítica.
Imunidade	Pelos anticorpos maternos, nas primeiras semanas de vida: • Pela vacina • Pela doença

Quadro 6.1. Vacina oral contra a poliomielite (SABIN)

Tipo de vacina	Vírus atenuado bivalente (I e III)		
Número de doses e intervalo entre as doses	Dois reforços: um reforço aos 15 meses e outro aos 4 anos (nos casos de esquema atrasado, o intervalo mínimo entre a terceira dose (VIP) e o primeiro reforço, e entre os dois reforços é de 6 meses).		
Idade recomendada	15 meses para o 1º reforço e 4 anos para o segundo reforço.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	-20°C	Observar o prazo de validade do produto. • Bisnaga Multidose: Utilizar por cinco dias após aberto o frasco e por três meses após o descongelamento (dependendo do laboratório produtor); • Frasco Multidose com conta-gotas: utilizar por 28 dias após aberto frasco, sob refrigeração (+2°C a +8°C).
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Oral		
Dose (volume)	Duas gotas (ou conforme laboratório produtor)		
Eficácia esperada	Após a terceira dose, com VOP a eficácia é de 90 a 95%, para os três sorotipos.		

Indicações	- Indicado primeiro e segundo reforço; - Em campanhas: a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e apenas para aqueles que já tenham 3 doses de VIP, independente da data da última dose ou de outras doses já recebidas; - Não há necessidade de intervalo antes e após a mamada; - Não repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a administração da vacina; - Em caso de diarreias severas e vômitos intensos deve-se adiar; - Pessoas com 5 (cinco) anos de idade ou mais, sem comprovação vacinal ou com esquema incompleto, deverão receber a VOP, excepcionalmente, se forem viajantes residentes no Brasil que estiverem se deslocando para áreas com recomendação da vacina. - Pacientes viajantes: Seguir a Nota Informativa 315/2021 - CGPNI/DEIDT/SVS/MS.
Contraindicações	- É contraindicada para os contatos de imunodeprimidos; - Ver as contraindicações de caráter geral e para as vacinas vivas; - É contraindicada a vacinação com VOP em hospitais pela possibilidade de transmissão do vírus vacinal a pacientes imunodeprimidos.
Eventos adversos	Poliomielite pós-vacinal em cerca de um caso para 5.000.000 de doses aplicadas, sendo 10.000 vezes mais frequentes em imunodeprimidos.

Quadro 6.2. Vacina inativada contra a poliomielite (VIP ou SALK)

Tipo de vacina	Vírus inativado trivalente (I, II e III).		
Número de doses e intervalo entre as doses	Três doses, aos 2, 4 e 6 meses. Com intervalo de 60 dias (intervalo mínimo de 30 dias).		
Idade recomendada	2, 4 e 6 meses.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2ºC a +8ºC	Depois de aberto utilizar em 28 dias ou conforme orientação do laboratório produtor.
	Regional	+2ºC a +8ºC	
	Local	+2ºC a +8ºC	
Via de administração	Intramuscular		
Dose (volume)	0,5 ml (ou conforme laboratório produtor)		

Eficácia esperada	Após a terceira dose, com VIP a eficácia é de 90 a 95%, para os três sorotipos.
Indicações	Na rotina para toda criança aos 2, 4 e 6 meses.
Contraindicações	Nenhuma contraindicação prática, apenas as de caráter geral.
Eventos adversos	Locais: eritema, enduração, hiperestesia.

Quadro 7. Características gerais do rotavírus

Agente etiológico	Vírus RNA (ácido ribonucleico), família Reoviridae, gênero rotavírus
Reservatório	O homem e os animais.
Modo de transmissão	Fecal – oral, de pessoa a pessoa ou por meio de fômites.
Período de incubação	Em média, de um a dois dias.
Transmissibilidade	Principalmente no 3º e 4º dias dos sintomas, persistindo por tempo indeterminado.
Suscetibilidade	Universal, principalmente em crianças de 6 meses a 2 anos.
Imunidade	• Pela doença; • Pela vacina, imunidade contra os vírus utilizados na vacina e imunidade cruzada para gastroenterites causadas por outras cepas não G1.

Quadro 7.1. Vacina rotavírus

Tipo de vacina	Vírus vivo atenuado, monovalente, cepa RIX 4414, sorotipo G1(P8)	
Número de doses	Duas doses: o paciente que não receber a primeira dose também não deve receber a segunda. Nunca se repete a dose.	
Idade recomendada	2 meses e 4 meses Idade mínima de 1 mês e 15 dias e máxima de 3 meses e 15 dias para a primeira dose; idade mínima de 3 meses e 15 dias e máxima de 7 meses e 29 dias para a segunda dose. Intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.	
Conservação	Nível da Temperatura	Tempo de duração
	Central +2°C a +8°C	Até a validade do produto. Depois de aberto, utilizar imediatamente ou conforme orientação do laboratório produtor.
	Regional +2°C a +8°C	
	Local +2°C a +8°C	

Via de administração	Oral
Dose (volume)	1,5ml dependendo do laboratório produtor
Eficácia esperada	70% para todas as formas de diarreia, 86% para as formas graves de diarreia e 80% para hospitalização por rotavírus.
Duração de imunidade	Não há estudos sobre a persistência da imunidade.
Contraindicações	• Imunodeficiência congênita ou adquirida; • Uso de corticoide em dose imunossupressora; • Uso de imunossupressor; • Presença de doença gastrointestinal crônica; • Má formação congênita do trato digestivo; • História prévia de intussuscepção; • Presença de diarreia ou vômito intenso (que levem a desidratação).
Eventos adversos	• Muito comum: irritabilidade; • Comum: perda do apetite, diarreia, vômito, flatulência, dor abdominal, febre, fadiga; • Incomum: constipação, sonolência, distúrbio do sono; • Raros: câibras, dermatite, exantema, rouquidão, rinorreia.
Administração com outras vacinas	• A vacina Rotavírus Humano Vivo Atenuado Oral pode ser administrada concomitantemente ou com qualquer intervalo de tempo entre as demais vacinas monovalentes ou combinadas. • Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose.

Quadro 8. Características gerais das pneumonias por pneumococo

Agente etiológico	Bactéria capsulada <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Direta, pelas vias respiratórias, ou indireta, por objetos contaminados pelas secreções respiratórias.
Período de incubação	Não estimado com precisão, podendo ser de 1 a 3 dias
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Pela doença; • As vacinas não conjugadas contra o pneumococo conferem imunidade relativa e de curta duração. As vacinas conjugadas conseguem promover imunidade duradoura.